

قضايا مجتمعية (الموضوع الأول)

أولا المشكلات المترتبة على الزيادة السكانية.

- النمو السكاني السريع ظاهرة تتميز بها كثير من الدول النامية مثل (مصر) وتعني **(انخفاض مستوى الوفيات في هذه الدول انخفاضا سريعا ومفاجئا، دون أن يقابله انخفاض مماثل في مستوى المواليد).**
- تتمثل المشكلة السكانية في ٣ ابعاد رئيسية وهي
- **النمو السكاني السريع – التوزيع الجغرافي غير المتوازن – الانخفاض في مستوى خصائص السكان**
- تحتل مصر المرتبة ال ١٦ بين دول العالم من حيث حجم السكان وتعتبر ثالث دولة أفريقية بعد نيجيريا وأثيوبيا وأكبر دولة عربية في عدد السكان.
- **الزيادة السكانية = عدد المواليد – عدد الوفيات + عدد المهاجرين.**
- تعتبر الهجرة الخارجية ظاهرة حديثة نسبيا في مصر حيث لم تبدأ بشكل ملحوظ نسبيا، إلا بعد حرب أكتوبر ١٩٧٣، وتتسم الهجرة في مصر في أغلب الأحيان بأنها هجرة مؤقتة.
- تتمثل أهم أسباب ارتفاع معدلات المواليد وبالتالي حجم السكان في
- **الزواج المبكر-ارتفاع معدلات وفيات الأطفال الرضع-نظرة المجتمع للمرأة - استمرار ثقافة تفضيل إنجاب الذكور خاصة في الريف-عدم الفهم الصحيح للدين.**
- **معدل المواليد** عدد المواليد لكل ١٠٠٠ من السكان
- **معدل الوفيات** عدد الوفيات لكل ١٠٠٠ من السكان.
- **معدل الزيادة الطبيعية** الفرق بين المواليد والوفيات لكل ألف من السكان.
- **متوسط العمر عند الميلاد** متوسط السنوات المتوقع أن يعيشها الفرد
- **الكثافة السكانية** عدد السكان لكل كيلو متر مربع من مساحة الدولة
- **معدل الإعالة السكاني.** النسبة ما بين عدد السكان المعالين في غير سن العمل (الأقل من ١٥ سنة، والأكثر من ٦٤ سنة) مقارنة بالسكان في سن العمل (من ١٥ ل ٦٤ سنة)
- يعتبر **معدل وفيات الأطفال الرضع** مؤشر هام للحالة الصحية.
- أدى الانخفاض المستمر في معدلات الوفيات بصفة عامة، ومعدلات وفيات الرضع بصفة خاصة لارتفاع متوسط العمر عند الميلاد (للذكور من ٦٠,٥ سنة عام ١٩٨٦ إلى ٧٣ سنة عام ٢٠٢٠) و(للإناث من ٦٣,٥ سنة عام ١٩٨٦ إلى ٧٥ سنة عام ٢٠٢٠).
- تقدر المساحة المأهولة بالسكان في مصر بـ ٧,٨٪ من جملة المساحة الكلية.
- تبلغ الكثافة السكانية الكلية في مصر ٩٨,٤ نسمة / كم^٢، بينما تبلغ الكثافة الفسيولوجية - وهي الكثافة السكانية على أساس المساحة المقبولة - أكثر من ألف ١٤٤٨ نسمة / كم^٢ طبقا لتقديرات عام ٢٠١٩.
- تختلف الكثافة الفسيولوجية من محافظة لأخرى، ففي محافظة القاهرة أكثر من ٥٠,٠٠٠ نسمة / كم^٢ مع ارتفاعها أكثر من ذلك بكثير في بعض الأحياء كما تبلغ أدناها في محافظات الحدود.

- تتمثل أعلى نسبة سكان في محافظة القاهرة ١٠,٥ % من إجمالي سكان الجمهورية وأقل نسبة سكان لمحافظة جنوب سيناء ٢,٢٪ من إجمالي السكان. أما نسبة سكان القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية) فتبلغ ٢٥٪ تقريبا.
- تعاني مصر من انخفاض مستوى الخصائص السكانية، والتي تتمثل في عدة مظاهر منها: -
اختلال التركيب العمري للسكان، ارتفاع نسبة الأطفال، ارتفاع نسبة الأمية، انخفاض مساهمة الإناث في القوى العاملة، ارتفاع معدل البطالة، تعرض نسبة من الأطفال لسوء حالة التغذية، معاناة نسبة من السكان من الفقر، تزايد ظاهرة السكن في العشوائيات.
- أدت الزيادة السريعة في حجم السكان وارتفاع مستوى الخصوبة حتى منتصف الثمانينيات إلى اتساع قاعدة الهرم السكاني في مصر
- يشهد المجتمع تحولا ديموجرافيا نحو ارتفاع تدريجي في نسبة المسنين (أكثر من ٦٠ عام).
- أدى الاختلال في التركيب العمري للسكان إلى الارتفاع النسبي فيما يعرف ب معدل الإعالة السكاني.
- يعد ارتفاع نسبة الأمية أحد المؤشرات التعليمية التي تعتبر من تداعيات النمو السكاني.
- لا تزال نسبة مساهمة الإناث في قوة العمل منخفضة.
- كذا البطالة في سن الشباب خاصة بين الإناث الحاصلات على مؤهلات متوسطة.
- تعد ظاهرة سوء حالة التغذية للأطفال أحد مظاهر تنامي الفجوة الغذائية - أحد المحددات الأساسية لصحة الطفل ونموه.
- ترتفع نسبة الفقر في الريف عنه في الحضر، كما ترتفع في الصعيد مقارنة بالدلتا، وتزداد في المناطق العشوائية. كما أن هناك ارتباط وثيق بين معدلات الفقر والزيادة السكانية على مستوى الأسرة والمجتمع.
- يقدر عدد سكان المناطق العشوائية بما يزيد عن ١٦ مليون نسمة - والله في عيشة غير آدمية تفتقر للمرافق الأساسية والمعاناة من الفقر والبطالة.
- من تداعيات الزيادة السكانية انخفاض نصيب الفرد من المياه حيث وصل متوسط نصيب الفرد ٥٠٠ م٣ فقط. طبقا للمؤشرات الدولية، إذا انخفض نصيب الفرد عن ١٠٠٠ م٣ فإن هذا يعبر عن معاناة الدولة وسكانها من الفقر المائي.
- من تداعيات الزيادة السكانية أيضا انخفاض نصيب الفرد من الأرض الزراعية حيث وصل متوسط نصيب الفرد من الأرض الزراعية إلى ٠,١ فدان. كذلك محدودية الأمن الغذائي، فهناك فجوة غذائية تقدر ب ٦٠٪ من جملة الإنتاج. ويتطلب ذلك زراعة ٦ مليون فدان وتوفير ٦ مليار م٣ مياه للقضاء على هذه الفجوة.
- كنتيجة للفقر المائي والفجوة الغذائية، مع زيادة مستمرة للسكان، زاد الاعتماد على الاستيراد لتوفير احتياجات المجتمع من الغذاء. حيث أصبحت مصر مستوردة لحوالي ٨٠٪ من احتياجاته الغذائية.
- الاعتماد على الخارج في توفير بعض الاحتياجات في الطاقة فكلما زاد عدد السكان زادت الفجوة اتساعا، وزادت التبعية للخارج، ومن ثم زادت الفاتورة التي كان من الممكن استخدامها في تحسين جودة الحياة.
- كذلك من تداعيات الزيادة السكانية ارتفاع كثافة الفصول، خاصة في مرحلة التعليم الابتدائي إلى ما يزيد عن ٨٠ إلى مئة تلميذ في الفصل الواحد. بما يؤثر على درجة استيعاب تحصيل التلاميذ وعلى المستوى التعليمي.

- مع تزايد أعداد السكان، تزايدت المشاكل الاجتماعية والاقتصادية بين السكان مثل **تزايد معدلات الجريمة، وتفاقم مشاكل المرور وظاهرتي أطفال الشوارع والبلطجة.**
- **فضلا عن تلوث البيئة،** تمثل الزيادة المستمرة في عدد السكان زيادة في الضغط على الموارد البيئية المتاحة، **خاصة الموارد غير المتجددة، كالبترول،** زيادة استهلاك الأعداد الهائلة من السكان التي قد لا تتلاءم مع الإنتاج خاصة الغذاء مما قد يسبب **حدوث مجاعات.**
- من المقدر أن يصل عدد سكان مصر عام ٢٠٥٠ إلى **أكثر من ١٤٠ مليون نسمة.**
- على الرغم من الجهود المبذولة، فإنه سوف تستمر الزيادة المطردة في حجم السكان **لطبيعة الهيكل العمري والنوعي للسكان،** الذي يتميز بزيادة نسبة الأطفال والشباب، **ارتفاع معدلات الخصوبة منذ منتصف القرن الماضي.**
- تنفيذ السياسات والاستراتيجيات السكانية بأسلوب علمي سليم يمكن أن يحقق لمصر الاستفادة مما يعرف ب **الفرصة الاقتصادية أو الهبة الديموغرافية.**
- **الفرصة الاقتصادية أو الهبة الديموغرافية،** أي تنفيذ سياسات واستراتيجيات سكانية وتنموية فعالة تؤدي لانخفاض معدلات الخصوبة لعدة عقود، وتناقص نسبة الأطفال إلى السكان في سن العمل. ومن ثم، تناقص معدلات الإعالة.
- تنقسم السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الهبة الديموغرافية إلى **سياسات واستراتيجيات سكانية، وسياسات واستراتيجيات التنمية البشرية.**
- تهدف السياسات والاستراتيجيات السكانية إلى: -
- **الحد من النمو السكاني، خفض الكثافة السكانية وإعادة توزيع السكان، الارتقاء بخصائص السكان.**
- تهدف سياسات واستراتيجيات التنمية البشرية إلى: -
- **حياة صحية ملائمة- فرص التعليم المؤهلة بكفاءة لسوق العمل - حصول السكان على الموارد اللازمة لمستوى معيشة لائق**

ثانيا الصحة الإنجابية ومبادئ تنظيم الأسرة

- أحد الاستراتيجيات القومية والعالمية للحد من الفقر وتحسين المستوى المعيشي للأسر، تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين. **الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.**
- تشمل برامج الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. مختلف الأبعاد الأسرية، الاجتماعية والصحية والثقافية مثل **تقديم التطعيمات- خدمات الرعاية الأولية - متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده.**
- **الصحة الإنجابية** قدرة الناس على التمتع بحياة مرضية ومأمونة، وأن يكونوا قادرين على الإنجاب، ولديهم حرية اختيار توقيت وكيفية القيام بذلك. وتطبيق برامج التثقيف الصحي للتأكد من الحصول على فترة حمل وولادة آمنين، وتوفير أفضل فرص للأزواج للحصول على طفل سليم.
- **الصحة الإنجابية جزء أساسي من الصحة العامة يعكس المستوى الصحي للرجل والمرأة في كافة المراحل العمرية** وليس سن الانجاب فقط
- تشمل حزمة خدمات الصحة الإنجابية **٣ فئات** وهم الأطفال والمراهقين المرأة. للزوجين معا.
- الفئات التي تستهدفها خدمات الصحة الإنجابية: -
الأطفال والمراهقون فيما يخص **صحة الطفل والمشاكل الخاصة بالصحة الإنجابية والجنسية**
النساء وتقديم خدمات **الأمومة الآمنة – رعاية ما بعد الحمل والولادة - الاكتشاف المبكر للأورام**
الزوجين من خلال خدمات **تنظيم الأسرة الشاملة-علاج المشاكل الصحية الخاصة بالإنجاب كالعقم والأمراض-الوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيا.**
- من أهم رسائل الصحة الإنجابية.
رعاية ما قبل الزواج. تأخير إنجاب الطفل الأول. دور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
المباعدة بين الولادات. منع زواج الأطفال. ضرورة تعليم الإناث. الحد من زواج الأقارب لتجنب الأمراض الوراثية الناجمة عنه
- من الآثار الاجتماعية الناجمة عن الزواج المبكر. **انتشار العنف الأسري. انتشار الفقر. انخفاض مستوى التعليم.**
- **تنظيم الأسرة** عمل منظم يقوم به الأزواج لتنظيم الخصوبة والتحكم فيها إما بتأخير، أو المباعدة، أو الحد من عدد الولادات. يتم ذلك من خلال برنامج عمل منظم لتوفير معلومات وخدمات تنظيم الأسرة لخفض الخصوبة وتحسين الصحة العامة. **وهي أحد أهم محددات الزيادة السكانية.**
- يرجع تغيير معدلات الخصوبة إلى **٤ عوامل مباشرة، هي تنظيم الأسرة، الإجهاض المتعمد، سن الزواج، والرضاعة.**